

CASO CLÍNICO



PABLO MARTINEZ

PROBLEMÁTICA

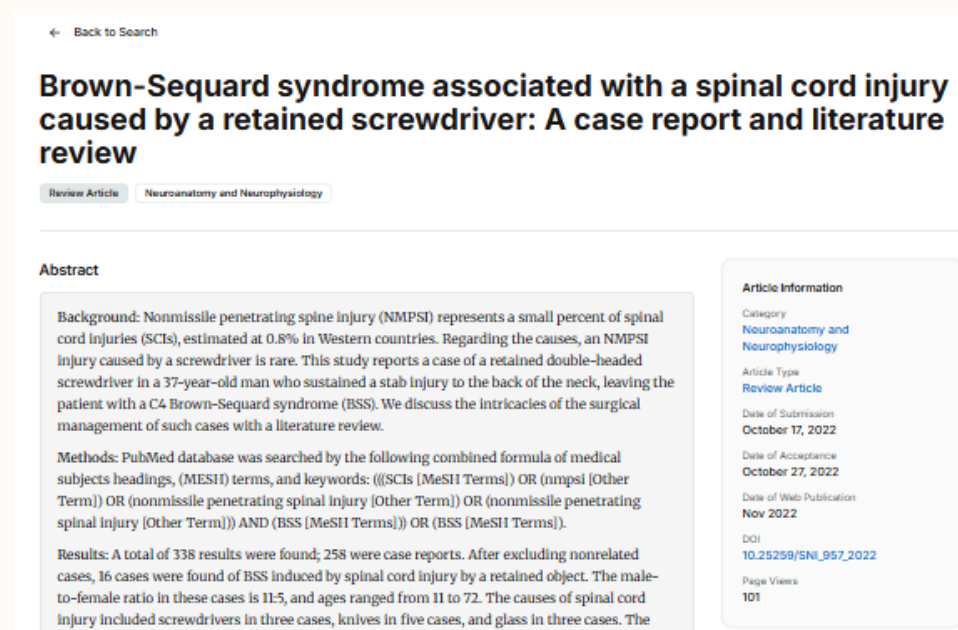
(1.60 m | 63 kg)

Lesión C4 AIS D

Objetivo: Corregir marcha compensatoria
e incrementar independencia

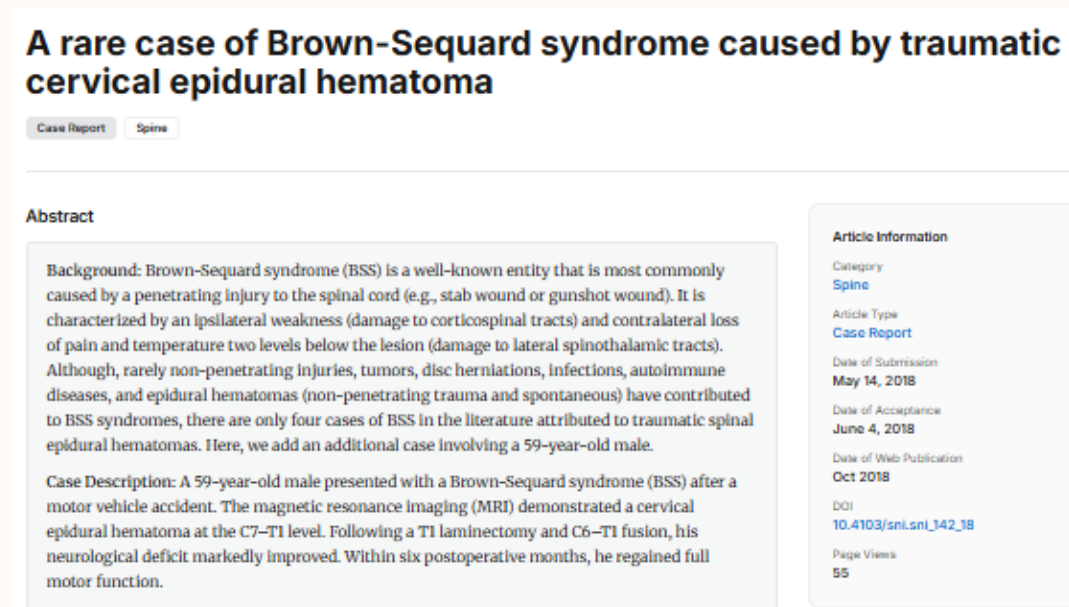


CASOS REFERENCIALES:



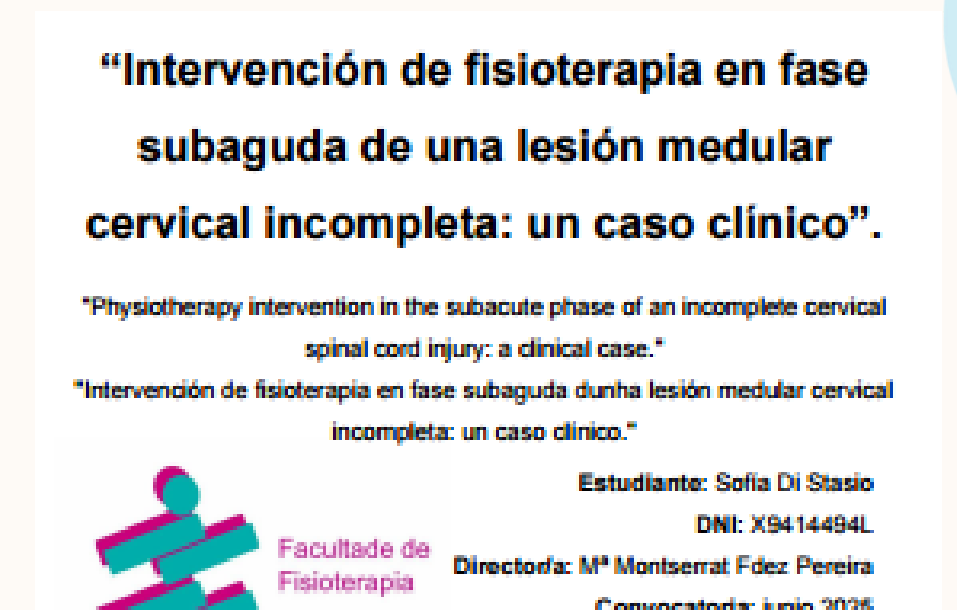
CASO 1

Hombre de 37 años con lesión medular cervical penetrante por destornillador a nivel de C4, compatible con síndrome de Brown-Séquard. Presentó debilidad predominante del lado derecho, alteraciones sensitivas y retención urinaria.



CASO 2

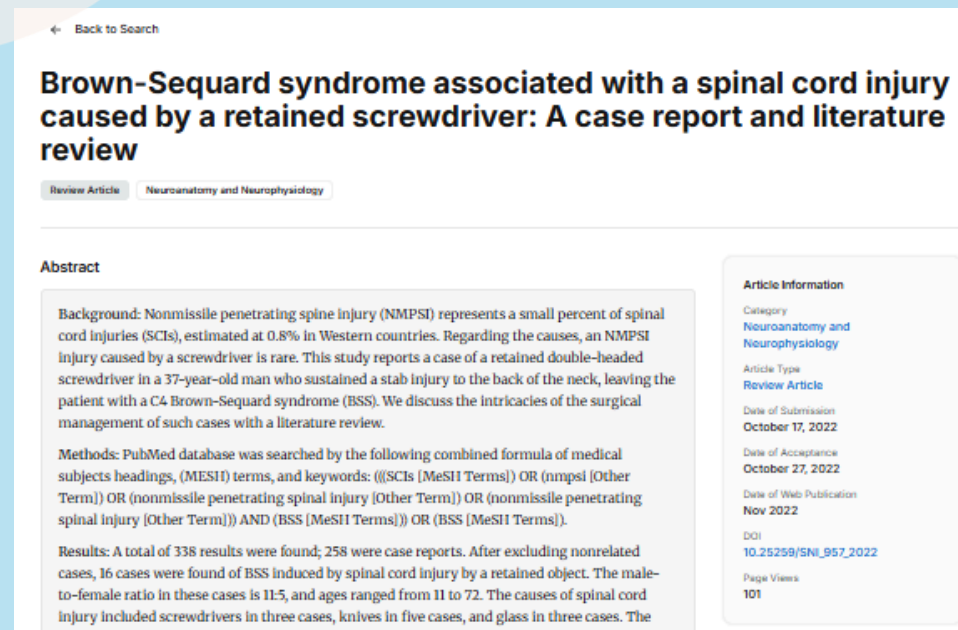
Hombre de 59 años que sufrió un accidente vehicular y desarrolló un hematoma epidural cervical en C7–T1, causando síndrome de Brown-Séquard. Presentó debilidad principalmente del lado izquierdo y fue tratado con laminectomía.



CASO 3

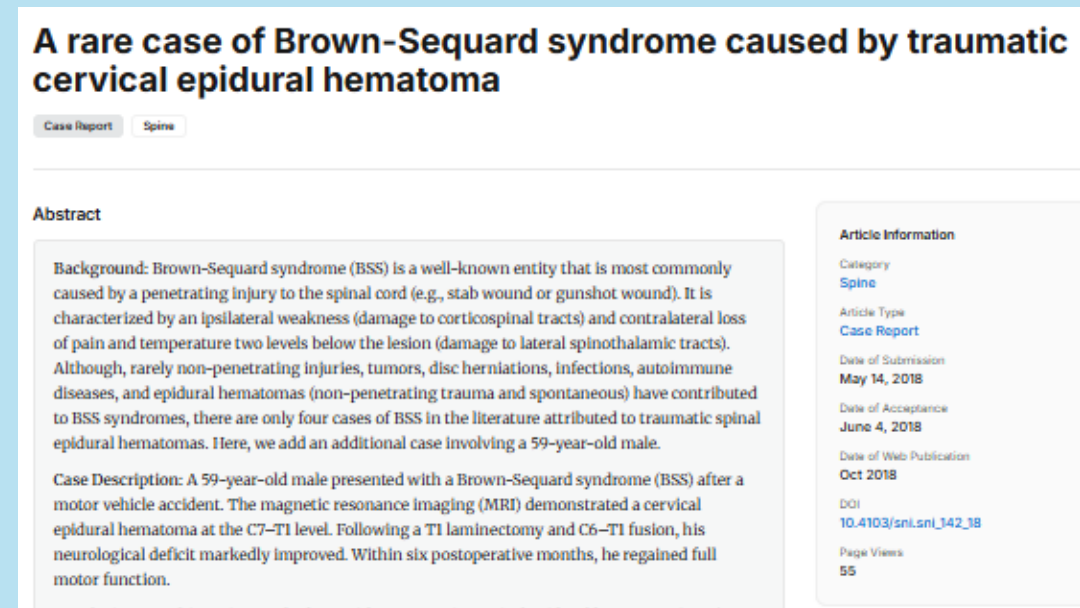
Hombre de 74 años con lesión medular cervical incompleta C5 AIS C después de una caída por escaleras. Presentó tetraplejía, debilidad en miembros superiores e inferiores y necesitó rehabilitación para recuperar la marcha y la independencia.

RELEVANCIA PARA EL PACIENTE:



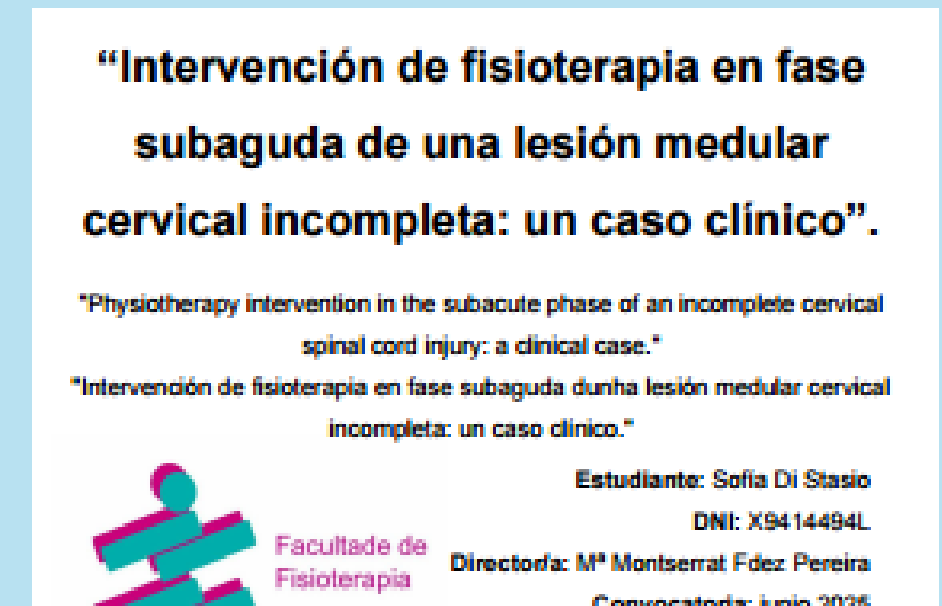
CASO 1

Es el caso más parecido al nuestro porque comparte el nivel C4, el mecanismo penetrante y el mayor compromiso del lado derecho.



CASO 2

Se relaciona porque ambos tienen una lesión cervical traumática, déficit motor asimétrico y requirieron tratamiento quirúrgico mediante laminectomía.



CASO 3

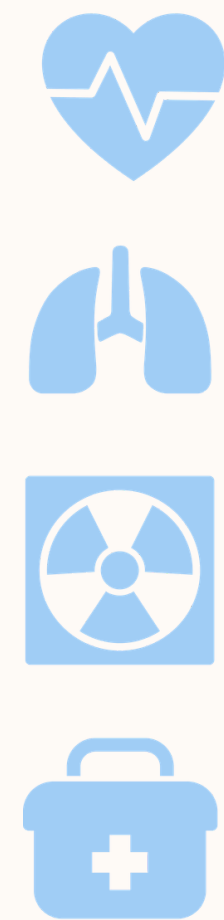
Se parece a nuestro paciente porque ambos presentan lesión medular cervical incompleta, dificultades para caminar, disminución de fuerza y uso de ayudas como andador y silla de ruedas.

PERFIL FUNCIONAL

Lesión medular C4 AIS D con recuperación progresiva, mejor función en el lado izquierdo y uso de andador, dorsiflexor y silla de ruedas según distancia. Persiste debilidad y espasticidad en el lado derecho, con marcha compensada y ayuda parcial en AVD. Evaluado con ASIA C4 AIS D y Ashworth 2, complementable con SCIM III, WISCI II y TUG para medir independencia y riesgo de caídas.



MAPA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS



VIDA DIARIA

VESTIRSE

Caminar con
andador y
dorsiflexor

**DESPLAZARSE
EN SILLA DE
REUDAS**

LABORAL/COMUNITARIO

SUPERVISAR
TRABAJO

USAR
TRANSPORTE
PÚBLICO

ASISTIR A
REUNIONES

REHABILITACIÓN

TERAPIA
FÍSICA

EQUILIBRIO

USO DE
DISPOSITIVOS

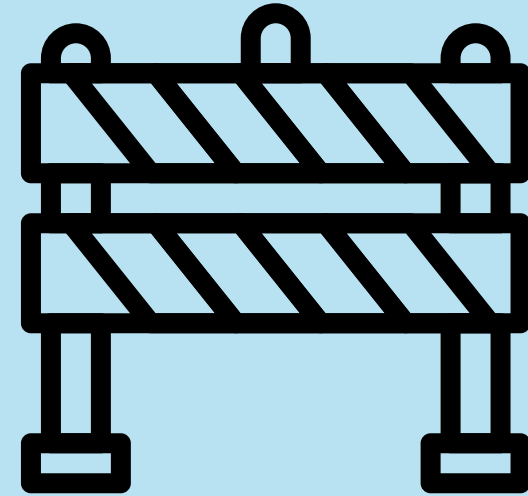
PREVENCIÓN/PROGRESIÓN

USO DEL
DORSIFLEXOR

USO DE
ANDADOR

CUIDADO DE
LA PIEL

BARRERAS



Limitación en manos
(dolor/acartonamiento) y
marcha inestable

Dependencia en vestirse,
comer y transferencias.

Inseguridad y TOC fuera del
entorno clínico.

FACILITADORES



Esposa e hijos capacitados
como cuidadores

Alta motivación y adherencia
del usuario.

Equipo interdisciplinar y guías
de autogestión.

MAPA DE DOLOR

Actividad

Descripción



Manipulación y agarre

Acortamiento y dolor que impiden cerrar el puño.



Transferencias

Dependencia física total para cambiar de posición.



Descanso nocturno

Interrupción constante del sueño por dolor recurrente.



Esfuerzos físicos

Molestias por dolor neuropático al moverse

EXPECTATIVAS



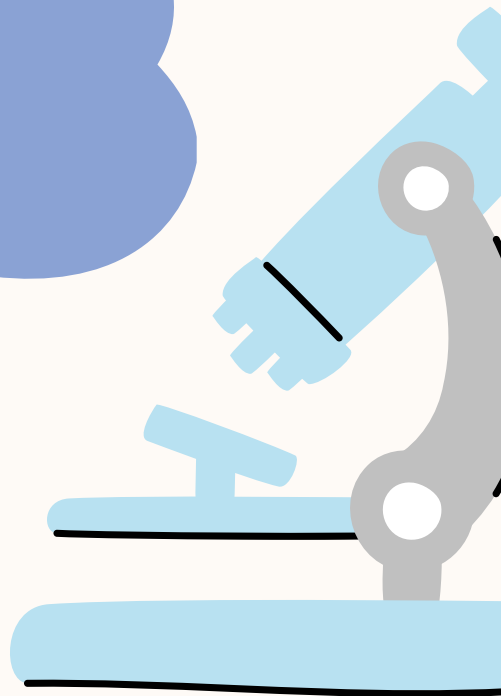
ASEO PERSONAL

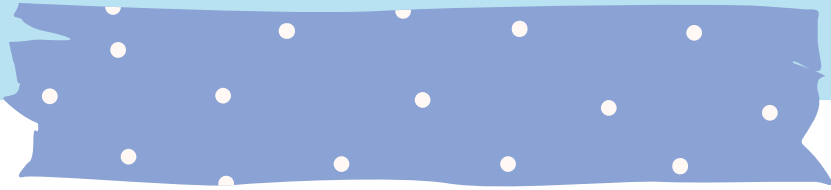
AUTONOMÍA EN
AVP

ALIMENTARSE

TRANSFERENCIAS

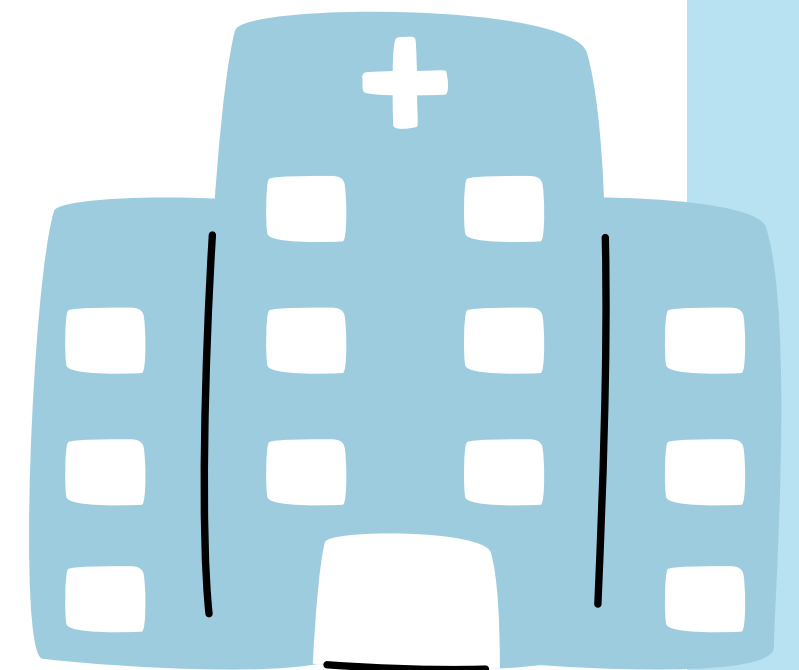
VESTIRSE





REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- M. N. Abdulqader et al., “Brown-Sequard syndrome associated with a spinal cord injury caused by a retained screwdriver: A case report and literature review,” Surgical Neurology International, vol. 13, Nov. 2022, doi: 10.25259/SNI_957_2022.
- A. Alhashash, A. Alghamdi, A. Alghamdi, and M. Alghamdi, “A rare case of Brown-Sequard syndrome caused by traumatic cervical epidural hematoma,” Surgical Neurology International, vol. 14, 2023.
- Di Stasio, S. (2025). Intervención de fisioterapia en fase subaguda de una lesión medular cervical incompleta: un caso clínico [Trabajo de Fin de Grado no publicado]. Universidade da Coruña.



CENTRO MÉDICO BORCELLE

**GRACIAS POR
VUESTRA ASISTENCIA**

